

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.V – 29 (NEU)	Bezeichnung des Dokumentes: Standard Mobilitätsförderung in Anlehnung an den Abschlussbericht zum Nationalen Expertenstandard „Erhaltung und Förderung der Mobilität“ (2014)	

Durchführende:

- Pflegefachkraft, Pflegefachperson, Betreuungskraft

Ziele:

Jeder pflegebedürftige Mensch erhält eine Unterstützung, die zur Erhaltung und/oder Förderung der Mobilität beiträgt.

Mobilität wird bewertet durch:

den historischen Status/biografischen Status der Mobilität (was war früher vorhanden):

Dekubitus-Risiko, akute/chronische Schmerzen, Kontrakturen bzw. Gelenkbewegungseinschränkungen, Sturzgefährdung, inklusive Probleme beim Treppensteigen, Probleme im Ernährungsmanagement, Motivation zur Bewegung, hat sich bisher aktivieren lassen, verfügt über genügend Wissen zur individuellen Mobilitätsförderung, Umsetzung anderer iatrogenen Maßnahmen, schwierige bautechnische Bedingungen, Umsetzung pflegerischer Bewegungskonzepte, Umsetzung physiotherapeutischer Maßnahmen, schwierige soziale Versorgungssituation (deren Motivation, Wissen, Kompetenzen, Fähigkeiten), schwierige materielle Situation

den aktuellen Status der Mobilität (was ist vorhanden):

- **Individuelle körperliche Beeinträchtigungen und Ressourcen:** Dekubitus-Risiko, akute/chronische Schmerzen, Kontrakturen bzw. Gelenkbewegungseinschränkung, Probleme im Ernährungsmanagement
- **Individuelle kognitive Beeinträchtigungen und Ressourcen:** Sturzgefährdung, Probleme beim Treppensteigen, ungenügendes Wissen zur individueller Mobilitätsförderung, fehlende Motivation sich zu bewegen, lässt aktivierende Hilfen nicht zu
- **Merkmale der materiellen und sozialen Umgebung:** schwierige soziale Versorgungssituation, schwierige materielle Situation, schwierige bautechnische Bedingungen
- **Erkrankungen und aktuell durchgeführte therapeutische Maßnahmen:** Umsetzung pflegerischer Bewegungskonzepte, Umsetzung physiotherapeutischer Maßnahmen, Umsetzung anderer iatrogenen Maßnahmen

Indikation:

- bei Mobilitätseinschränkungen durch intrinsisch (Erkrankungen) und extrinsisch (z.B. FEM) begründete Bewegungseinschränkungen

Kontraindikation:

- bei Ablehnung des Patienten
- bei Diagnosen und Anordnungen, die das Mobilisieren untersagen

Vorbereitung:

- Patienten informieren
- Informationssammlung/Anamnese

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023	30.03.2023	002	I	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.V – 29 (NEU)	Bezeichnung des Dokumentes: Standard Mobilitätsförderung in Anlehnung an den Abschlussbericht zum Nationalen Expertenstandard „Erhaltung und Förderung der Mobilität“ (2014)	

Material/Hilfsmittel:

- Rollator, Unterarmgehstützen, Gehbänkchen
- Aufstehhilfen, Orientierungshilfen, Stützvorrichtungen, Haltegriffe
- für Übungszwecke: Bälle, Gewichte, elastische Bänder etc.

Durchführung:

- Die erste pflegfachliche Einschätzung zur Mobilität erfolgt bei Aufnahme zu den individuellen pflegesensitiven Risiken und Phänomenen (ja-nein) ergibt sich aus den Erkenntnissen der Situationseinschätzung im Themenfeld „Mobilität“ unter Berücksichtigung der vorgenannten Status der biografischen und aktuellen Mobilität durch die PFK in der „Strukturierten InformationsSammlung“ (SIS).
- Nach Abschluss der SIS sind alle relevanten Pflegerisiken aus dem Themenfeld „Mobilität“ in der Matrix als pflegfachliche Einschätzung zu bewerten.
- Liegen Einschränkungen der Mobilität vor ist die Maßnahmenplanung anzulegen bzw. anzupassen
- Kommt ein späteres Problem neu hinzu oder ist dieses Problem verschwunden erfolgt eine Eintragung im Berichtblatt und die Anpassung des Maßnahmenplanes
- ist eine Beratung erfolgt, wird dies inhaltlich kurz im zutreffenden Themenfeld beschrieben und auf der SIS angekreuzt, später notwendig werdende Beratungen sind im Berichtblatt zu beschreiben
- grundsätzlich dient das Berichtblatt zur Erfassung veränderter pflegerischer Situationen als anlassbezogene Evaluation in akuten Situationen oder bei besonderen Ereignissen oder Veränderungen,
- Hinweise aus den Formulargutachten des jeweils gültigen Begutachtungsinstrumentes (BI) für den Pflegegrad sind zu berücksichtigen.
- Hinweise auf die Mobilität aus anderen Nationalen Expertenstandards und aktuellem Wissen zu Medizin, Pflege und Recht sind mit zu berücksichtigen.
- Feststellen von Vorlieben und Motivationen zur Bewegung,

Maßnahmen der Förderung der Mobilität können sein:

- Vorrang hat aktive Einbeziehung in Mobilitätsangebote
- Integration von mobilitätsfördernden Aspekten in Alltagsaktivitäten
- alltägliche pflegerische Maßnahmen
- körperliche Aktivität, aufgabenbezogenes Gehtraining, Nutzen von Gruppenübungen (soweit möglich)
- Umsetzung von Bewegungsübungen
- Gestaltung der räumlichen Umgebung
- Nutzung von Hilfsmitteln
- Umsetzung der 3-Schritt-Therapie nach Zegelin
- alltagsintegrierte Maßnahmen
- aktive Bewegungsübungen
- aktiv-assistive Bewegungsübungen
- isometrische Spannungsübungen
- Lageveränderungen, Sitzen auf der Bettkante, Sitzen im Sessel
- Gehen mit Unterstützung
- Gehen mit Mobilisationshilfen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023	30.03.2023	002	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.V – 29 (NEU)	Bezeichnung des Dokumentes: Standard Mobilitätsförderung in Anlehnung an den Abschlussbericht zum Nationalen Expertenstandard „Erhaltung und Förderung der Mobilität“ (2014)	

- Beschäftigung, sozialer Kontakt, Tanzen, sportliche Übungen (auch im Wasser), Einsatz von Spielekonsolen, Tablets
- Stärkung der Kraft, z.B. mit Geräten, elastischen Bändern, Hanteln, Spannungsübungen, etc.
- Übungen der Balance, z.B. Ganzkörperwiderstandsübungen, Sitz-Stand-Übungen, Ganzkörpervibration
- Stärkung der Beweglichkeit, z.B. Übungen zur Erweiterung des Bewegungsausmaßes, Verlängerung der Gehzeit
- Gangübungen
- Durchführung regelmäßiger Informations-, Beratungs- und Edukationsangebote
- Gestaltung einer motivierenden, mobilitätsfördernden und sicheren Umgebung
- Abstimmung und Fortsetzung von bewegungsfördernden interprofessionellen Maßnahmen

Nachbereitung:

- Hygienemaßnahmen durchführen
- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Verweigerungen/Ablehnung von Maßnahmen zur Mobilisierung
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL – Kommunikation mit dem Arzt

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023	30.03.2023	002	3	Verw./MA